

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090424-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MIZAEI GONCALVES TEIXEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS: APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA NASAL TAMANHO M. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. STJ. RESP 1.657.157. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA, na forma do art. 300 do CPC, conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS, forneçam ao autor em, no máximo 72 (setenta e duas) horas, a partir da intimação, os insumos: APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR e MÁSCARA NASAL TAMANHO M, pelo que fixo, de fato, a multa diária de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, limitada ao total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos entes federativos, a qual tinha sido mencionada na decisão do evento 19, a contar do 4º. (quarto) dia do descumprimento, e que pode ser majorada pelo Juízo a quo, não afastada a adoção das demais medidas coercitivas aplicáveis à espécie. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5090424-91.2024.4.02.5101

510015369451 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090424-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MIZAEI GONCALVES TEIXEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pelo autor **Mizael Gonçalves Teixeira** em face da decisão proferida pelo Juízo *a quo* nos autos principais n. 5087537-37.2024.4.02.5101 (evento 03), a qual indeferiu a antecipação de tutela.

Em sede de medida cautelar, com pedido de antecipação de tutela, requer que os réus recorridos, de forma solidária, forneçam à parte autora os insumos: APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR e MÁSCARA NASAL TAMANHO M, em razão do diagnóstico de apneia obstrutiva do sono grave, conforme receituário acostado aos autos.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

"[...]"

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

[...]"

Sustenta o recorrente que possui diagnóstico de SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) (C10 G47.3), de grau SEVERO, apresentando hipertensão arterial sistêmica, motivo pelo qual lhe foi indicada terapêutica com APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR e MÁSCARA NASAL TAMANHO M.

Afirma que o laudo médico deixou consignado também que há risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e morte súbita caso não inicie o tratamento. Assim, requereu a reforma da decisão *a quo* que denegou a tutela de urgência.

No evento 19, foi proferida decisão por esta Juíza Relatora deferindo o pedido de liminar de antecipação de tutela, a fim de que os réus fornecessem, no prazo de 15 (quinze) dias, os insumos requeridos.

Os réus foram intimados para apresentar resposta ao recurso, mas não se manifestaram, apesar de terem sido regularmente intimados.

É o relatório. Decido.

VOTO

Consoante decisão proferida no evento 19, reafirmo que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da obrigação estatal prevista no art. 196 da Constituição Federal, reconheceu a responsabilidade solidária dos três entes federativos para prestar serviços de saúde à população. Neste sentido:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. **O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.** Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)

No presente caso, encontram-se presentes os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.657.157, quais sejam: a presença cumulativa de: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Verifico que a parte autora foi diagnosticada com SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) (C10 G47.3) de grau SEVERO, com indicação de uso de aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) automático com umidificador e

máscara NASAL, conforme laudo médico juntado nos autos originários (Evento 1, ANEXO2, pág. 11):

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Paciente Miguel Gonçalves Teixeira
48 anos, apresentando as seguintes comorbidades: hipertensão
arterial sistêmica
realizou polissonografia em 20/05/24
que evidenciou as seguintes alterações: IAH: 79.3 | IA: 76.3 | IA: 3.0
IA: 23.6 | IDO 72 | Nad nasal 96.1 | Nad min 76.1 | Ruído
64.9 | T90 = 55 min 28.7.
estabelecendo diagnóstico de Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS)
de grau leve (CID-10 G47.3)
A apnéia obstrutiva do sono é fator de risco para doenças
cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica e arritmias cardíacas,
além de se relacionar a maior risco de infarto agudo do miocárdio, acidente
vascular encefálico e morte súbita. O prejuízo ao sono resulta em sonolência
excessiva diurna e dificuldade de concentração, que também aumenta o risco
de acidentes automobilísticos e laborativos.
O tratamento padrão-ouro para a apnéia obstrutiva do sono consiste no
uso de aparelho de pressão positiva contínua na via aérea (CPAP), que deve
ser iniciado o mais rápido possível e não tem previsão de término.
Recomendo o uso de CPAP automático com umidificador e máscara
nasal de tamanho M.
Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 27/09/24

Como visto, a médica deixou consignado que há maior risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e morte súbita, caso o autor não inicie o tratamento.

O NAT esclareceu que os itens pleiteados estão indicados ao manejo do quadro clínico do autor, além de possuírem registro na ANVISA, conforme evento 17 (PARECER1) dos autos originários:

Cabe esclarecer que a abordagem dos distúrbios respiratórios do sono com uso de **pressão positiva contínua nas vias aéreas** é considerada a **forma mais eficiente de tratamento**. É realizada por meio de aparelho apropriado - CPAP que se adapta a um tubo flexível através do qual o ar liberado pelo aparelho é conduzido até uma **máscara** firmemente adaptada ao nariz do paciente. Os portadores de distúrbios **graves** bem como os moderados sintomáticos, aderem facilmente a essa forma de tratamento². A **Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS)** pode resultar em doença

cardiovascular, o que inclui a hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca esquerda, infarto do miocárdio, arritmias e hipertensão pulmonar, podendo culminar com morte súbita³. É interessante notificar que para apnéia moderada a acentuada o uso de gerador de pressão positiva contínua na via aérea (CPAP) durante o período do sono é o **tratamento de escolha**⁴.

Assim, informa-se que o uso do aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho **M** **está indicado** ao manejo do quadro clínico do Autor - Apnéia Obstrutiva do Sono **severo** (Evento 1, ANEXO2, Página 11).

O NAT informou também que, de acordo com a CONITEC, o CPAP é financiado pelo Ministério da Saúde (MS) para entidades públicas (Secretarias de Saúde, hospitais etc.) e privadas sem fins lucrativos (entidades beneficentes), não sendo dispensado diretamente aos pacientes. Assim, não se encontra padronizado em nenhuma lista de equipamentos/insumos para dispensação no SUS no âmbito do município de São Gonçalo e do Estado do Rio de Janeiro, bem como não foram identificados outros equipamentos que possam configurar alternativa, não havendo programas nas esferas governamentais que atendam à necessidade terapêutica do autor.

Pois bem, na hipótese em tela, verifico que restou demonstrada nos autos, a priori, a imprescindibilidade dos insumos requeridos para o tratamento da parte autora, sendo certo, ainda, que não há substitutos terapêuticos no âmbito do SUS e a demandante é parte hipossuficiente, assistida pela DPU, como comprovam os documentos juntados com a inicial.

Portanto, preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC.

Precedente desta Turma nos autos do RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5020262-08.2023.4.02.5101/RJ, concedendo a tutela antecipada, ratificada por unanimidade na sessão de julgamento de 02/06/2023.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso para **CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA**, na forma do art. 300 do CPC, conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS, forneçam ao autor em, no máximo 72 (setenta e duas) horas, a partir da intimação, os insumos: APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR e MÁSCARA NASAL TAMANHO M, pelo que fixo, de fato, a multa diária de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, limitada ao total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos entes federativos, a qual tinha sido mencionada na decisão do evento 19, a contar do 4º. (quarto) dia do descumprimento, e que pode ser majorada pelo Juízo a quo, não afastada a adoção das demais medidas coercitivas aplicáveis à espécie. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.

5090424-91.2024.4.02.5101

510015369450 .V4